有用なパニック値報告に向けての取り組み

◎加納 若奈[1)]、中島 佳那子[1)]、田間 沙耶[1)]、辻 佐江子[1)]、西村 はるか[1)]、宇城 研悟[1)]
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪市民病院[1)]

【はじめに】パニック値は、「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値」であり、発覚後すみやかに医師へ直接報告するだけでなく、対応履歴などを明確にする必要があり、運用方法に関して各施設で様々な取り組みがなされている。当院では、検体検査の一部（血液・生化学・免疫検査）を隣接する松阪地区医師会臨床検査センターへ委託しており、パニック値報告についても一任していたが、臨床検査「パニック値」運用の提言書(2024 年改訂版)をもとに、当院中央検査室によるカルテ記載を含むパニック値報告体制を構築し、2025 年 5 月より運用を開始した。【目的】運用当初、医師への連絡方法やカルテ記載のマニュアルは作成したが、技師間で検体の状態や投薬状況、治療の影響など臨床経過に伴う結果値の変動に対する知識の差が大きく、不要な報告が散見された。今回、パニック値報告の除外する取り組みを行ったので報告する。【取り組み内容】患者の状態把握（心肺停止、透析、投薬状況など）、検体の状態（溶血、乳び、血小板凝集、フィブリン析出など）を把握した上で報告できるよう、当日のパニック値一覧を確認し、考慮すべきパニック値報告に対して報告者とディスカッションし、毎日終業時に行われている中央検査室全体のミーティングで情報共有を行った。【結果】2025 年 5 月～2026 年 5 月までの約 1 年間に確認されたパニック値は 2081 件であった。取り組み前である 2025 年 5 月～2026 年 2 月ではパニック値 1561 件に対し報告した件数は 806 件（51.6%）であったが、毎日情報共有を行う取り組みを行った後の 2026 年 3 月～5 月ではパニック値 520 件に対し、報告した件数は 226 件（43.4%）となった。【考察】運用当初は報告項目の選別に技師間の差があったが、中央検査室全体や技師間での意見交換や情報共有を繰り返し行い、マニュアルを随時更新することで改善したと考える。今後の課題として、当院の設定パニック値が 20 項目と推奨されている項目より多いため、厳選していくべきだと考える。【結語】今後も業務改善を重ね、より意義のあるパニック値報告を行うために模索していきたい。

連絡先：0598-23-1515